



Préparation à l'accès à l'examen de troisième cycle des études médicales

Thème 65 : Les syndromes coronariens aigus

P. Mehdi SLIM

Dr. Houda GHARDALLOU

Faculté de Médecine de Sousse

Année universitaire 2024-2025

PARTIE 1 : QCM

1) La classification des syndromes coronariens aigus repose sur :

- A. La durée de la douleur thoracique
- B. Les anomalies du segment ST à l'ECG
- C. L'élévation des troponines ultrasensibles
- D. Les anomalies de l'onde T à l'ECG
- E. L'état hémodynamique du patient à l'admission

2) Concernant le syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST:

- A. L'angor instable en est une entité
- B. Le dosage des troponines permet de distinguer l'angor instable de l'infarctus sans sus-décalage de ST (NSTEMI)
- C. Les douleurs surviennent à l'effort
- D. Les troponines ont une valeur pronostique
- E. L'ECG peut être normal en intercritique

3) Concernant les artères coronaires, la/les propositions suivantes sont exactes:

- A. Le tronc commun coronaire gauche se divise en artère interventriculaire antérieure et artère marginale.
- B. L'artère circonflexe donne des branches pour la paroi postéro-latérale du ventricule gauche.
- C. L'artère coronaire droite irrigue la majorité du tissu nodal.
- D. La circulation coronarienne est de type anastomotique fonctionnelle chez l'adulte sain.
- E. L'artère interventriculaire antérieure donne des branches pour la paroi antérieure du VG et le septum interventriculaire

4) L'artère interventriculaire antérieure :

- A. Est la principale artère coronaire
- B. Donne des branches marginales pour la paroi antérieure du VG
- C. Donne des branches diagonales pour la paroi latérale du VG
- D. Se termine dans la partie moyenne du sillon interventriculaire
- E. Donne des branches septales pour le septum interventriculaire

5) La coronaire droite :

- A. naît du sinus postérieur
- B. Vascularise le nœud sinusal
- C. donne deux branches terminales
- D. vascularise le nœud auriculo ventriculaire
- E. vascularise la paroi antérieure du VG

6) L'artère circonflexe :

- A. naît du sinus antéro gauche
- B. chemine dans le sillon auriculoventriculaire droit
- C. Vascularise la paroi inféro basale du ventricule gauche
- D. donne une artère interventriculaire postérieure en cas de dominance gauche
- E. vascularise la paroi antérieure du ventricule gauche

7) Un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST inférieur peut être en rapport avec une occlusion :

- A. du tronc commun gauche
- B. de l'interventriculaire antérieure
- C. de la circonflexe
- D. de la coronaire droite

E. de la diagonale

8) À propos de la physiopathologie des SCA, la ou les propositions suivantes sont exactes :

- A. La rupture de plaque induit un syndrome coronarien aigu.
- B. Une plaque vulnérable a une chape fibreuse fine et un cœur lipidique important.
- C. L'activation plaquettaire suit la rupture ou l'érosion de plaque.
- D. Une occlusion partielle ou transitoire ne donne pas une élévation des troponines.
- E. Un spasme coronaire contribue à l'aggravation de la réduction de la perfusion.

9) Le principal facteur de rupture d'une plaque d'athérosclérose est :

- A. la prolifération des cellules endothéliales
- B. la migration des cellules musculaires lisses
- C. l'infiltration par des cellules inflammatoires
- D. l'accumulation des lipoprotéines dans les macrophages
- E. l'épaississement de la chape fibreuse

10) Quelles sont les conséquences métaboliques de l'ischémie myocardique ?

- A. Augmentation de l'acide lactique
- B. Augmentation du métabolisme anaérobie
- C. Augmentation de la relaxation diastolique
- D. Accumulation de l'acide pyruvique
- E. Augmentation de l'oxygénation cellulaire

11) En dehors de l'athérosclérose coronaire, un SCA peut être dû à :

- A. un spasme coronaire prolongé
- B. Une embolie coronaire

- C. une vascularite coronarienne
- D. une anémie aiguë
- E. une dissection spontanée de l'artère coronaire

12) La rupture d'une plaque d'athérome coronaire aboutit à :

- A. Activation de la cascade de la coagulation
- B. Formation d'un thrombus riche en fibrine et en plaquettes
- C. Exposition du contenu lipidique de la plaque
- D. Inhibition de l'agrégation plaquettaire
- E. Spasme coronaire réflexe

13) Concernant la physiopathologie du syndrome coronaire aigu sans sus-décalage persistant du segment ST (SCA ST-), quelles propositions sont correctes ?

- A. Rupture ou érosion d'une plaque d'athérome avec thrombose partielle
- B. Spasme coronaire aggravant l'ischémie
- C. Occlusion coronarienne complète et persistante d'un gros tronc épigastrique
- D. Micro-embolisation distale responsable de nécroses myocardiques focales
- E. élévation des troponines ultra sensibles

14) La cascade ischémique au cours des syndromes coronariens aigus comprend :

- A. un métabolisme aérobie avec production de lactates
- B. une ascension des troponines
- C. une douleur thoracique
- D. une altération de la fonction diastolique
- E. une augmentation de la fréquence cardiaque

15) À propos de la cascade ischémique au cours d'un syndrome coronaire aigu, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les troubles de la repolarisation précèdent l'apparition de la douleur thoracique
- B. L'altération de la fonction systolique précède l'altération de la fonction diastolique
- C. Les signes cliniques constituent la dernière étape de la cascade ischémique
- D. Les modifications hémodynamiques sont les premières anomalies détectables
- E. Les perturbations métaboliques traduisent une activation du métabolisme anaérobie

16) Les caractéristiques sémiologiques suivantes des douleurs angineuses vous orientent vers un syndrome coronarien aigu:

- A. Durée brève 1-2 minutes
- B. survenue au repos
- C. résistance à la trinitrine
- D. rétrosternales et constrictives
- E. irradiation vers le dos et descendante

17) Les caractéristiques sémiologiques de la douleur thoracique angineuse comprennent :

- A. De type d'oppression ou de brûlures
- B. Augmente à l'inspiration profonde
- C. Récidivantes
- D. Irradiation dorsale et descendante
- E. Soulagée par la position penchée en avant

18) Au cours du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST, les anomalies ECG sont caractérisées par :

- A. L'évolutivité en fonction du temps
- B. La présence d'une image en miroir
- C. Le caractère systématisé
- D. La normalité de l'électrocardiogramme au cours des premières minutes suivant l'occlusion coronaire
- E. L'apparition des ondes q de nécrose

19) Au cours d'un syndrome coronarien sans sus-décalage persistant du segment ST, l'électrocardiogramme peut montrer :

- A. un sous-décalage diffus du segment ST avec un sus-décalage en AVR
- B. des ondes T négatives en antérieur
- C. un sous décalage de PQ
- D. un sus-décalage diffus de ST
- E. une absence d'anomalies en inter critique

20) Indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s). La correspondance entre les dérivations ECG et le siège d'un infarctus du myocarde est la suivante :

- A. D2 - D3 - aVF : STEMI inférieur
- B. D1 - aVL - V5 - V6 : STEMI antérieur
- C. D1 - aVL - V1 - V2- V3 : STEMI septal profond
- D. V1 à V6 : STEMI antérieur étendu
- E. D2 - D3 - aVF - V5 - V6 : STEMI inféro-latéral

21) Les anomalies électriques suivantes sont observées au cours du syndrome coronarien avec sus décalage persistant du segment ST :

- A. onde T positive, ample, pointue et symétrique.
- B. sus décalage ST, concave vers le haut, englobant l'onde T avec un sous décalage en miroir dans les dérivations opposées.
- C. Sus décalage d'au moins 1 mm dans au moins deux dérivations contigües.
- D. Négativation de l'onde T en quelques heures à quelques jours
- E. onde Q de nécrose large > 0,04 s et profonde > à 1/3 R

22) Concernant la troponine ultrasensible I (Tn I) :

- A. Elle est détectable dans la circulation à partir de la 6^{ème} heure
- B. Une insuffisance rénale peut être responsable de son élévation
- C. Est exprimée en nanogramme/litre (ng/L)
- D. son élévation est proportionnelle à l'étendue de l'infarctus
- E. Se normalise en 3 à 5 jours

23) Le dosage de la troponine ultrasensible au cours du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST (SCA ST-) :

- A. a un intérêt diagnostique
- B. constitue le marqueur de nécrose myocardique le plus sensible
- C. Une cinétique à la hausse signe une lésion myocardique aiguë
- D. Son élévation classe la patient à très haut risque
- E. A un intérêt pronostique

24) Concernant la stratification du risque ischémique au cours des syndromes coronariens aigus sans sus-décalage de ST :

- A. L'élévation des troponines classe le patient à haut risque
- B. Distingue trois niveaux de risque
- C. La présence d'arythmie ventriculaire menaçante indique une coronarographie dans les 2h
- D. Permet de guider la stratégie invasive
- E. Un score GRACE > 140 identifie des patients à très haut risque

25) Les éléments suivants orientant vers une coronarographie urgente (<2H) en cas de syndrome coronariens aigu sans sus-décalage de ST?

- A. Instabilité hémodynamique ou choc cardiogénique
- B. Insuffisance cardiaque aiguë réfractaire au traitement médical
- C. Arrêt cardiaque ressuscité sans sus décalage de ST ou choc cardiogénique
- D. Tachycardie ventriculaire récidivante
- E. Modifications dynamiques du segment ST

26) Un syndrome coronarien aigu sans sus décalage de ST est considéré à haut risque devant :

- A. Un arrêt cardiaque ressuscité sans sus décalage de ST ou choc cardiogénique
- B. une insuffisance cardiaque aiguë liée au SCA
- C. Un diagnostic établi de SCA avec des troponines positives
- D. Modification dynamique du segment ST et de l'onde T

E. un Score de Grace <140

27)La stratification du risque hémorragique au cours des syndromes coronariens aigus sans sus décalage de ST (SCA ST(-)) :

- A. permet d'adapter le traitement anti thrombotique
- B. Le score de Crusade permet d'évaluer le risque hémorragique
- C. La présence d'un critère majeur du score ARC HBR définit un risque hémorragique élevé
- D. un âge > 60 ans est un critère majeur
- E. un haut risque contre indique le traitement par les inhibiteurs de la P2Y12

28)En dehors des syndromes coronariens aigus, une élévation des troponines peut être observée dans :

- A. Une insuffisance cardiaque aigue
- B. Un accident vasculaire cérébral étendu
- C. Une dissection de l'aorte type A
- D. Un rétrécissement mitral
- E. Une insuffisance rénale aigue

29)Sont considérés comme des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs non modifiables ?

- A. L'âge >50 ans chez l'homme et >60 ans chez la femme
- B. Le diabète sucré
- C. Le tabagisme actif
- D. L'HTA traitée ou non
- E. L'hérédité coronaire

30)Sont considérés comme des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs modifiables :

- A. Homme $\geq$ 50 ans
- B. Femme $\geq$ 60 ans

- C. Antécédent familial d'infarctus du myocarde (IDM) ou de mort subite chez un parent au premier degré de sexe masculin d'âge ≤ 55 ans
- D. HTA
- E. Diabète sucré

31) Les complications suivantes peuvent survenir au cours d'un STEMI antérieur lié à une occlusion aigue de l'artère interventriculaire antérieure :

- A. Etat de choc cardiogénique
- B. Insuffisance mitrale aigue
- C. BAV complet nodal
- D. Trouble du rythme ventriculaire.
- E. Extension de l'infarctus au ventricule droit.

32) Concernant l'insuffisance cardiaque à la phase aigüe du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST, quelles affirmations sont correctes ?

- A. C'est une complication rare sans impact pronostique
- B. Elle peut être due à une complication mécanique ou à une arythmie.
- C. L'échocardiographie transthoracique précoce est recommandée pour évaluer la fonction cardiaque.
- D. La classification de Killip permet de graduer la sévérité de l'insuffisance cardiaque.
- E. Le stade Killip 1 correspond à un œdème aigu du poumon

33) L'état de choc cardiogénique compliquant le syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant de ST :

- A. Complique 20% des SCA avec sus décalage persistant de ST
- B. est une indication urgente à la réalisation d'une échographie cardiaque au lit du patient
- C. est une contre-indication à une reperfusion par fibrinolyse
- D. Est défini par une hypotension persistante (<90 mmHg) associées à des signes d'hypo perfusion d'organes

- E. est une indication à un traitement inotrope intraveineux et une assistance ventriculaire mécanique

34)Un syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant de ST antérieur compliqué d'un état de choc primaire se manifeste par les signes suivants :

- A. Une turgescence des veines jugulaires
- B. Une tachycardie
- C. Un pouls radial imprenable ou filant
- D. Une froideur des extrémités
- E. Des râles crépitants diffus à l'auscultation pulmonaire

35)Concernant les troubles du rythme ventriculaire à la phase aiguë du SCA avec sus décalage de ST :

- A. Leur survenue n'est pas corrélée à l'étendue de l'ischémie
- B. Constituent la principale cause de mortalité pré hospitalière
- C. Une cardioversion électrique est nécessaire en cas de mauvaise tolérance
- D. La tachycardie ventriculaire est souvent monomorphe.
- E. Les bêta bloquants sont recommandés en l'absence de contre-indications

36)Concernant le BAV complet compliquant un SCA avec sus décalage de ST dans le territoire antérieur :

- A. La fréquence cardiaque est lente et les QRS sont larges
- B. Il est secondaire à une nécrose du NAV
- C. Il est de siège supra hissien
- D. La régression est la règle après reperfusion
- E. Peut se compliquer d'une asystolie

37)Une échographie doppler cardiaque est indiquée à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST :

- A. Systématiquement dès l'arrivée à l'USIC pour étayer le diagnostic
- B. En urgence en cas de complication type choc cardiogénique
- C. En urgence en cas de souffle à l'auscultation cardiaque initiale
- D. Devant un bloc auriculoventriculaire complet compliquant un STEMI inférieur

- E. Devant une tachycardie ventriculaire survenue immédiatement après la fin d'une thrombolyse

38) La rupture de la paroi libre du ventricule gauche compliquant le SCA avec sus-décalage de ST est caractérisée par :

- A. La rupture aiguë est responsable d'un hémopéricarde conduisant à un collapsus brutal
- B. L'âge avancé et la fibrinolyse tardive sont des facteurs de risque de rupture aiguë
- C. Est devenue une complication rare
- D. Le diagnostic est confirmé par l'échocardiographie
- E. Est d'évolution favorable en cas de reperfusion urgente

39) Quelle est parmi ces propositions la principale cause de mortalité dans les STEMI dans les premières heures ?

- A. Communication interventriculaire
- B. Etat de choc cardiogénique
- C. Œdème aigu du poumon
- D. BAV complet nodal
- E. Fibrillation ventriculaire

40) Les arythmies ventriculaires à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST :

- A. constituent la première cause de mortalité
- B. justifient un monitoring immédiat du rythme dès la suspicion diagnostique
- C. Peuvent être de mécanisme adrénergique
- D. Leur survenue est corrélée à l'étendue de l'ischémie
- E. Sont une indication à la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable en prévention secondaire

41) La survenue d'une salve de rythme idioventriculaire accéléré (RIVA) à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde :

- A. est de mauvais pronostic

- B. traduit un infarctus étendu
- C. Ne nécessite aucun traitement
- D. Est un critère de reperfusion de la thrombose
- E. est une indication à un choc électrique externe en urgence

42) Au cours d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST, la présence de signes d'insuffisance ventriculaire droite doit faire évoquer les diagnostics suivants :

- A. Communication interventriculaire par rupture septale
- B. Une extension de l'infarctus au ventricule droit
- C. Une insuffisance mitrale aiguë ischémique
- D. Embolie pulmonaire grave
- E. Tamponnade par rupture de la paroi libre

43) Une patiente âgée de 75 ans consulte aux urgences pour douleur thoracique aiguë. Aux antécédents, on note une anémie chronique et une maladie rénale chronique (Cl créat=30 ml/min). La pression artérielle est à 80/60 mmHg, la fréquence cardiaque à 40/mn, les jugulaires sont turgescentes, l'auscultation pulmonaire est normale. A l'ECG, il existe un rythme sinusal avec un sus-décalage de ST en inférieur.

Les médicaments suivants, sont prescrits, selon la voie d'administration appropriée, pendant la phase pré hospitalière :

- A. Héparine non fractionnée
- B. Atropine
- C. Remplissage vasculaire prudent
- D. Dérivés nitrés
- E. Ticagrelor

44) Un souffle cardiaque d'apparition récente en phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST peut être en rapport avec :

- A. Une rupture de la paroi libre
- B. Une rupture d'un pilier de la valve mitrale
- C. Une dysfonction d'un pilier de la valve mitrale
- D. Un anévrysme du VG
- E. Une rupture septale

45)Après un syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST, la constitution d'un anévrisme ventriculaire peut être suspectée par :

- A. Une réaction péricarditique précoce et prolongée
- B. Une réascension des troponines
- C. Un accident thromboembolique
- D. Une tachycardie ventriculaire
- E. Un sus-décalage persistant du segment ST au-delà de 3 semaines dans le même territoire

46)L'extension de la nécrose myocardique au ventricule droit peut se traduire par :

- A. sus-décalage de ST dans les dérivations précordiales droites V3r et V4r
- B. Des signes d'insuffisance ventriculaire droite aigue
- C. Un état de choc cardiogénique
- D. un pouls paradoxal
- E. des râles crépitants

47)Concernant l'insuffisance mitrale aigue ischémique:

- A. La dysfonction ischémique du pilier en est le mécanisme principal
- B. La rupture complète du pilier réalise un tableau d'œdème aigu du poumon d'évolution rapidement fatale
- C. Le pilier postéro médian est le plus souvent touché car vascularisé par l'artère interventriculaire seule
- D. Est une indication à une contre pulsion intra aortique
- E. Peut être responsable d'un état de choc cardiogénique

48)Au cours du syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST, les délais suivants doivent être respectés :

- A. ECG dans les 10 minutes après le premier contact médical
- B. Si décision de fibrinolyse, celle-ci doit être réalisée dans les 10 minutes après le diagnostic

- C. Angioplastie primaire dans les 60 minutes si présentation dans un centre capable
- D. Coronarographie dans 2 à 24h après une fibrinolyse réussie
- E. Angioplastie de sauvetage dans les 24h après un échec de thrombolyse

49)Concernant la prise en charge syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST :

- A. Un monitoring immédiat du rythme doit être installé dès que le diagnostic est suspecté
- B. L'administration de l'agent fibrinolytique doit être effectuée en moins de 60 minutes
- C. Le jugement du résultat (succès ou échec) de la thrombolyse s'effectue 30 minutes après son début
- D. En cas de thrombolyse, le transfert immédiat des patients vers un centre avec une salle de cathétérisme cardiaque est indiqué
- E. L'angioplastie primaire est la stratégie de reperfusion préférée si elle peut être réalisée dans les 2 heures

50)Par rapport à l'angioplastie primaire, la thrombolyse offre les avantages suivants :

- A. Un coût moindre
- B. Un risque moindre de complications hémorragiques
- C. Une meilleure efficacité
- D. Une meilleure disponibilité
- E. moins de contre-indications

51)Concernant l'angioplastie coronaire à la phase aigüe d'un SCA avec sus décalage de ST:

- A. La voie fémorale est préférée à la voie radiale
- B. Une angioplastie de l'artère coupable est réalisée
- C. L'héparine non fractionnée (HNF) est l'anticoagulant de choix
- D. Le ticagrelor est prescrit à la dose de charge de 90mg
- E. L'administration d'un anti GpIIb/IIIa est indiquée en cas de charge thrombotique élevée

52) Un homme âgé de 60 ans, diabétique, tabagique actif consulte aux urgences pour une douleur thoracique aiguë d'installation brutale au repos depuis 30 min, paroxystique et récidivante sans autres symptômes associés. L'examen initial retrouve un patient algique, PA=180/100mmHg, FC=85BPM. L'auscultation cardiopulmonaire est normale et le reste de l'examen est sans particularités. Un ECG réalisé en urgence montre un rythme sinusal à 90c/min, un sous-décalage horizontal de 2mm du segment ST avec des ondes T négatives de V1 à V6. Le diagnostic d'un SCA sans sus-décalage du segment ST est retenu.

La prise en charge thérapeutique immédiate comportera :

- A. Hospitalisation en USIC
- B. Double anti-agrégation plaquettaire : Aspirine + ticagrelor
- C. Anticoagulation : Héparinothérapie à dose préventive
- D. Traitement anti-angineux : dérivés nitrés par voie intra-veineuse
- E. Une injection de diurétiques par voie intra-veineuse

Le bilan biologique réalisé en urgence montre : Troponines us à 4500 ng/l puis à 7000ng/l, Créatinine à 80 µmol/l (Clairance =91ml/min/1,73m²), Hémoglobine à 15 g/dl, glycémie=1.5g/l

La/les proposition(s) suivante(s) est/sont correcte(s) concernant le SCA chez ce patient :

- A. Le SCA est considéré à risque très élevé et la coronarographie est indiquée dans les 24h
- B. Le risque hémorragique est considéré faible
- C. Un pré-traitement par une dose de charge dP2Y12 inhibiteur est recommandé
- D. Le ticagrelor est l'anti-agrégant de choix
- E. L'aspirine est prescrite par voie orale à la dose de charge de 150 à 300mg

53) Les critères de succès de la reperfusion par fibrinolyse au cours du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST sont :

- A. Disparition de la douleur
- B. Régression du sus-décalage de ST > 50%
- C. Survenue d'un rythme idioventriculaire accéléré
- D. Pic précoce des troponines

E. Une artère coupable occluse à la coronarographie

54)Concernant la thrombolyse intra veineuse, les propositions suivantes sont correctes :

- A. La ténecteplase (TNK-tPA) est administrée en bolus IV selon le poids
- B. Une fois indiquée, elle doit être administrée en pré hospitalier
- C. Un accident cérébral hémorragique en est une contre-indication absolue
- D. L'héparine à bas poids moléculaire est l'anticoagulant de choix
- E. Le ticagrelor est prescrit à la dose de charge de 180mg

55)Le traitement anti-ischémique des SCA comporte :

- A. Les bêtabloquants
- B. Les anti P2Y12
- C. Les dérivés nitrés
- D. Les IEC
- E. Les statines

56)À propos du Clopidogrel, les propositions suivantes sont exactes :

- A. C'est une thiénopyridine sous forme de pro drogue.
- B. 85 % de la pro drogue sont oxydés en un métabolite hépatique par les cytochromes.
- C. Le métabolite actif du Clopidogrel inhibe de manière réversible les récepteurs P2Y12.
- D. Le Clopidogrel est actuellement déclassé par les nouveaux anti-P2Y12.
- E. Il est prescrit à la dose quotidienne de 75mg/jour

57)Le traitement anti thrombotique adjuvant à une fibrinolyse au cours du syndrome coronarien avec sus décalage de ST comporte :

- A. Prasugrel dose de charge 60 mg
- B. Ticagrelor dose de charge 180 mg
- C. Clopidogrel dose de charge de 600 mg

- D. Aspirine dose de charge 150-300mg per os
- E. Héparine non fractionnée bolus 60UI/Kg

58)Concernant les agents anti thrombotiques administrés dans le syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage de ST :

- A. Le prasugrel permet d'inhiber l'agrégation plaquettaire médiée par l'adénosine di phosphate
- B. Les inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa sont indiqués en salle de cathétérisme dans les situations à haut risque
- C. L'héparine non fractionnée présente une fenêtre thérapeutique étroite nécessitant un monitoring de son activité
- D. L'énoxaparine est contre-indiquée en cas de clearance de la créatinine inférieure à 15ml/min
- E. L'énoxaparine ne comporte pas de risque de thrombopénie induite à l'héparine

59)Concernant le prasugrel, quelles sont les propositions justes :

- A. C'est une pro drogue nécessitant une biotransformation hépatique pour libérer son principe actif.
- B. Il bloque le récepteur P2Y12 de manière réversible.
- C. Son délai d'action est plus rapide que celui du Clopidogrel.
- D. Il est plus efficace que le Clopidogrel pour prévenir les événements ischémiques
- E. Il est contre-indiqué chez les patients avec un antécédent d'AVC

60)Concernant le ticagrelor, quelles sont les propositions justes :

- A. est prescrit par voie intra veineuse
- B. est une pro drogue qui nécessite un métabolisme hépatique pour devenir actif
- C. l'inhibition plaquettaire est réversible
- D. Est prescrit à la dose de 60mg*2/jour
- E. Doit être arrêté 5 jours avant une chirurgie cardiaque

61)Concernant le traitement anti coagulant à la phase aigüe du syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST :

- A. L'héparine non fractionnée (HNF) comporte un risque de thrombopénie à l'héparine
- B. L'héparine à bas poids moléculaire nécessite un monitoring de l'activité anti Xa
- C. Le fondaparinux est indiqué quand une stratégie invasive précoce est réalisée
- D. Le fondaparinux est un inhibiteur sélectif du facteur Xa
- E. La bivalirudine est indiquée en cas d'antécédent de thrombopénie à l'héparine

62)Concernant la surveillance des patients après revascularisation d'un SCA :

- A. La surveillance clinique comprend la mesure des paramètres vitaux et l'auscultation cardio-pulmonaire biquotidienne.
- B. Le monitoring en continu du rythme est nécessaire les 1ères 24h.
- C. Le bilan biologique inclut un bilan métabolique (glycémie à jeun, bilan lipidique)
- D. Une échocardiographie est réalisée pour évaluer la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG)
- E. Une sortie précoce de l'hôpital dans les 48-72 heures est recommandée chez tous les patients

63)Indiquez-la ou les proposition(s) exacte(s). Les objectifs thérapeutiques au décours d'un syndrome coronarien aigu :

- A. LDL-C < 0.7 g/dl
- B. Un arrêt de l'intoxication tabagique
- C. 130 mm Hg < PAS < 140mmHg
- D. 80 mm Hg < PAD < 70 mm Hg
- E. HbA1C < 7%

64)Une patiente âgée de 63 ans diabétique, hypertendue a été hospitalisée pour un syndrome coronaire aigu avec sus décalage de ST revascularisé par angioplastie primaire et pose de stent. L'échographie cardiaque avant la sortie a montré une FEVG à 35%, Son bilan montre une HbA1C à 9%, un LDLc à 1g/l. Rédiger l'ordonnance de sortie de cette patiente

- A. Statine à forte dose
- B. IEC
- C. Sprinolactone
- D. Beta bloquant
- E. Simple anti agrégation plaquettaire pendant 1 an

PARTIE 2 : CAS CLINIQUES

Cas clinique 1 :

Une femme de 60 ans consulte les urgences pour une douleur thoracique constrictive depuis 30 minutes associée à une dyspnée aigue. Dans ses antécédents : un diabète sucré sous anti diabétiques oraux.

À l'arrivée, la patiente présentait les constantes suivantes :

PA = 100/60 mm Hg, FC = 100 bpm, FR = 25/min, T = 37°C, SaO₂ AA= 88% à l'air ambiant, glycémie à 1,5g/l

Auscultation cardiaque normale, Auscultation pulmonaire: râles crépitants aux 2 bases

Absence de signes périphériques de choc

ECG 12 dérivation est réalisé en urgence: Rythme régulier sinusal à 100/min, sus décalage du segment ST de 3mm de V1 à V6

QCM1 : Le diagnostic positif est:

- A. Syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST en antérieur non compliqué
- B. Syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST en inférieur compliqué de CIV

- C. Syndrome coronarien aigu sans sus décalage de ST en antérieur compliqué d'insuffisance ventriculaire gauche
- D. Syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST en latéral compliqué d'insuffisance mitrale aigue
- E. Syndrome coronarien aigu avec sus décalage de ST en antérieur compliqué de rupture de la paroi libre

QCM2 :Concernant la prise en charge initiale, la ou les propositions suivantes sont exactes:

- A. Une angioplastie primaire est indiquée en urgence dans un délai de 60 à 90 min
- B. Une thrombolyse IV est préférable si l'angioplastie ne peut être faite dans les 2 heures.
- C. L'aspirine et un inhibiteur P2Y12 doivent être administrés en doses de charge
- D. Un bêta bloquant doit être administré pour traiter la tachycardie
- E. Une héparinothérapie est indiquée par voie intra veineuse ou sous cutanée.

QCM3 : Parmi les propositions suivantes, la/lesquelle(s) sont exactes :

- A. Un traitement par statine à haute intensité quelque soit la cholestérolémie initiale
- B. La double anti agrégation plaquettaire est recommandée pendant au moins 12 mois.
- C. Un contrôle glycémique strict est recommandé compte tenu du diabète.
- D. La pression artérielle cible est inférieure à 130/80mmHg
- E. Un IEC est indiqué même en l'absence de dysfonction ventriculaire gauche

CAS CLINIQUE 2 :

Un patient âgé de 70 ans consulte aux urgences pour douleur thoracique angineuse. Dans ses antécédents, on note un tabagisme actif, un diabète sucré et un AVC ischémique il y a 3 mois. A l'examen, TA : 160/100 mm Hg, FC : 80bpm, FR : 18cpm et la SpO2 est à 96% AA. L'auscultation cardiopulmonaire est sans anomalies. L'électrocardiogramme montre un sous décalage de 3mm du segment ST en V5, V6 et en DII, DIII, aVF. Les troponines US = 3500 ng/l

Le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST est retenu

QCM1 : Selon les données cliniques et paracliniques, le risque ischémique chez ce patient serait :

- A. Faible
- B. Intermédiaire
- C. Elevé
- D. Très élevé
- E. Impossible à évaluer

QCM2 : La prise en charge de ce patient comportera :

- A. Exploration invasive par une coronarographie urgente dans les 2 heures
- B. Exploration invasive par une coronarographie dans les 24h
- C. Exploration invasive par une coronarographie dans les 72 h
- D. Surveillance en unité de soins intensifs coronaire avec un test d'ischémie passé la phase aigüe (j5)
- E. Exploration du réseau coronaire par un Coro scanner dans les 24 heures

QCM3 : Les mesures thérapeutiques suivantes sont à instaurer en urgence chez ce patient :

- A. Clopidogrel, dose de charge de 75 mg
- B. Ticagrelor, dose de charge de 180 mg

- C. Un diurétique par voie intra veineuse
- D. Prasugrel, dose de charge de 60 mg
- E. Une oxygénothérapie

QCM4 : L'ordonnance de sortie de ce patient comportera obligatoirement :

- A. unestatine à forte dose
- B. leclopidogrel 75 mg/j pendant 6 mois
- C. leprasugrel 10 mg/jour pendant 12 mois
- D. l'aspirine à la dose de 75 à 100 mg/jour à vie
- E. un inhibiteur de l'enzyme de conversion

CAS CLINIQUE 3 :

Un patient âgé de 50ans, tabagique actif, diabétique sous insuline consulte pour « douleur thoracique aigue et dyspnée »

A l'interrogatoire, il rapporte la notion de douleurs rétrosternales constrictives évoluant depuis 10h associées à une dyspnée avec orthopnée

A l'examen: PA=80/60mmHg, extrémités froides, FC=110bpm, Sat O2=82% AA.

Auscultation cardiaque normale, auscultation pulmonaire: râles crépitants diffus aux 2 champs pulmonaires

L'ECG réalisé a montré un rythme sinusal avec un BBG complet et un sus décalage de ST de V1-V6 et en D1-avL

QCM1 : Quel est votre diagnostic :

- A. SCA ST+ inférieur compliqué d'une extension au VD
- B. SCA ST+ antéro septo-apical compliqué d'une IM aigue
- C. SCA ST+ antérieur étendu compliqué d'un état de choc cardiogénique
- D. SCA ST+ circonférentiel non compliqué

E. SCA ST+ antérieur étendu compliqué de choc vagal

QCM2 : Votre conduite à tenir en urgence doit comporter les mesures suivantes:

- A. Un conditionnement et un monitoring du rythme
- B. Une oxygénothérapie par masque haute concentration
- C. Une dose de charge d'héparine+ double anti agrégation plaquettaire
- D. Une thrombolyse intra veineuse en urgence
- E. Une perfusion intra veineuse d'un agent inotrope positif

QCM3 : Quelle est à votre avis l'artère coupable de l'infarctus :

- A. L'artère interventriculaire antérieure
- B. L'artère circonflexe
- C. L'artère diagonale
- D. L'artère coronaire droite
- E. L'artère marginale

QCM 4 : Le pronostic ultérieur de ce patient dépendra de:

- A. La fonction ventriculaire gauche résiduelle
- B. L'arythmie ventriculaire à la phase aigue
- C. La tachycardie
- D. Le diabète
- E. L'âge du patient

CAS CLINIQUE 4 :

Un homme de 45 ans se présente aux urgences pour une douleur thoracique aiguë.
Il est tabagique, diabétique et hypertendu

La douleur était d'installation brutale, irradiant à la mâchoire associée à des vomissements et des sueurs froides. L'examen physique révèle un BMI à 37Kg/m², tension artérielle de 80/60 mmHg, une fréquence cardiaque de 40 bpm et une saturation en oxygène à 98 % à l'air ambiant.

L'ECG montre un sus-décalage du segment ST de 2mm en DII, DIII, ACF et en V3R, V4R, avec un BAV complet.

QCM1 : Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaires majeurs chez ce patient :

- A. Hypertension artérielle
- B. Diabète de type 2
- C. Tabagisme
- D. Antécédents familiaux de maladie coronarienne
- E. L'âge jeune de survenue de l'infarctus

QCM 2 : Quel est le diagnostic retenu chez ce patient :

- A. STEMI antérieur compliqué de BAV
- B. STEMI inférieur compliqué d'état de choc cardiogénique
- C. STEMI inférieur étendu au VD compliqué de BAV complet
- D. STEMI antérieur compliqué d'état de choc cardiogénique
- E. Péricardite aiguë

QCM3 : Quelle est la prise en charge initiale recommandée pour ce patient

- A. Administration de dérivés nitrés par voie sublinguale
- B. Administration d'une dose de charge d'aspirine
- C. Montée d'une sonde d'entraînement électro systolique
- D. Perfusion intraveineuse d'un agent chronotrope positif
- E. Angioplastie coronaire en urgence

